

Strategisch Implementatiekader: Digitale Familieparticipatie & Netwerkgroep 2040

1. De Strategische Urgentie: De Zorgkloof Richting 2040

De Nederlandse gezondheidszorg nadert een demografisch breekpunt dat rond 2040 zijn apex zal bereiken. De macro-economische realiteit dicteert dat stilzitten geen beleidsoptie is; het huidige, aanbodgestuurde model is failliet. De 'dubbele vergrijzing' creëert een onoverbruikbare kloof tussen de explosieve zorgvraag en de stagnerende arbeidsmarktcapaciteit. Zonder radicale herijking van de zorginfrastructuur zal de ongecontroleerde groei van zorguitgaven leiden tot een onaanvaardbare verdringing van vitale publieke investeringen in onderwijs, veiligheid en klimaat. De Raad van Bestuur dient de ernst van de onderstaande kerngetallen te internaliseren als de basis voor elke strategische beslissing: | Parameter | Waarde / Prognose 2040 | Strategische Implicatie || ----- | ----- | ----- || **Aantal 65-plussers** | 4,7 miljoen (>25% van de bevolking) | Verdubbeling van de vraag naar complexe ouderenzorg en langdurige steun. || **Benodigd personeel** | 2,0 miljoen zorgverleners | Maatschappelijk onhaalbare beslaglegging op de nationale arbeidsmarkt. || **Zorguitgaven** | Groeiratio 2x sneller dan de economie | Onhoudbare druk op de nationale begroting en het solidariteitsstelsel. || **Huidig tekort (2022)** | 80.000 zorgmedewerkers | Directe verdringing van zorgtoegankelijkheid en kwaliteit. |

Het personeelstekort in de VVT-sector (reeds 60.000 in 2022) dwingt ons tot een paradigmashift. We moeten de transitie maken van het maximaliseren van 'zorgcapaciteit' naar het ontsluiten van 'netwerkkraft'. Digitale participatie is hierbij geen secundaire IT-voorziening, maar de primaire architectuur voor een toekomstbestendige zorgverlening.

2. Paradigmashift: Van 'Zorgen Voor' naar 'Samen Zorgen'

De overlevingsstrategie voor 2040 rust op een diepe sociale transitie: de verschuiving van de professional als uitvoerende taakdrager naar de professional als facilitator van zelfredzaamheid. Technologie is hierin slechts een facilitator; de werkelijke innovatie zit in de herverdeling van regie en verantwoordelijkheid binnen het sociale netwerk van de cliënt.

Methodiek van Zelfmanagement (Het 5A-model)

De professional dient de autonomie van de cliënt structureel te versterken via een methodische benadering:

1. **Achterhalen:** Inventariseer gezondheidsvaardigheden en specifieke doelen van het netwerk.
2. **Adviseren:** Verskaf gerichte opties voor zelfmanagement en informele ondersteuning.
3. **Afspreken:** Kom tot concrete doelen op basis van gedeelde besluitvorming.
4. **Assisteren:** Ondersteun het netwerk actief bij het overwinnen van barrières.
5. **Arrangeren:** Organiseer vervolgondersteuning waarbij de formele zorg slechts de 'sluitpost' is.

Rolverdeling in Informele Zorg (SOFA & WIFA)

Voor een effectieve netwerkregie moet de professional de vier rollen van de mantelzorger (SOFA) beheersen: de naaste als **Partner** (co-zorgverlener), **Hulpvrager** (ondersteuningsbehoevende), **Persoonlijke relatie** (emotionele band) en **Expert** (unieke cliëntkennis). Bij de inzet van vrijwilligers is het **WIFA-model** (Waarderen, Informeren, Faciliteren, Afstemmen) leidend voor borging. Deze methodische transitie naar netwerkzorg is echter alleen schaalbaar indien ondersteund door een digitale architectuur die specifiek is ontworpen voor deze interacties.

3. Architectuur van Digitale Platforms: Een Vergelijkende Analyse

Een 'fit-for-purpose' technologiestrategie vereist een scherpe differentiatie tussen platforms op basis van de zorgcontext (intramuraal versus extramuraal). De Raad van Bestuur moet waken voor 'passief gebruik' en kiezen voor een platform dat de netwerkregie actief stimuleert.

Strategisch Vergelijkingstabel

Platform, Primair Focus, Kernfunctionaliteiten, Strategische Beperking / Risico
Familienet, Sociaal & Sfeer: Afstand verkleinen., "Levensboek, Agenda, Meehelp-oproep, Vrijwilligersnet.", Beperkt inzicht in medisch-inhoudelijk dossier; focus op welzijn.
CarenZorgt, Dossier & Transparantie: Inzagerecht., "Zorgrapportages (ECD), Zorgplan, Berichtenfunctie.", Groot risico op passief gebruik: Gebrek aan push-notificaties/app leidt tot lage alertheid bij naasten.
OZO, Netwerkregie: Multidisciplinair., "Signaalafgifte, taakbeheer, koppeling huisarts/apotheek.", Vereist actieve participatie van gemiddeld 24 actoren voor maximaal rendement.

De Business Case voor de Regio

De keuze voor **OZOverbindzorg** moet worden gezien als een regionale business case. Met een landelijke besparing van **€273 miljoen per jaar** (waarvan €104 mln. Zvw en €66 mln. Wmo) faciliteert dit platform de noodzakelijke verschuiving van institutionele zorg naar preventieve wijkzorg. Voor de professional betekent dit een radicale reductie van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA): de ongestructureerde communicatiestroom via zeven verschillende kanalen wordt gecentraliseerd naar één regie-instrument. **CarenZorgt** biedt de noodzakelijke transparantie via de Nedap ONS-koppeling, maar de Raad van Bestuur moet rekening houden met de gerapporteerde inlogdrempels en de passieve houding van familie door het ontbreken van een mobiele app.

4. De Professional in Regie: Autonomie en Arbeidsomstandigheden

Conform de **Arbovisie 2040** van de SER is digitale innovatie de enige methode om zorgprofessionals te behouden. In een markt met een tekort van 80.000 medewerkers is het verlagen van de administratieve regeldruk — een "doorn in het oog" — een strategisch imperatief.

SER-ambities en Professionele Autonomie

De Raad van Bestuur dient de SER-aanbeveling voor **"Professional Zeggenschap"** te borgen door professionals de regie te geven over de inzet van deze platforms. Digitale tools

moeten niet leiden tot meer werk, maar tot het elimineren van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Door de communicatie te stroomlijnen (van 7 kanalen naar 1), wordt incidentenpreventie mogelijk en worden de verwachtingen van de familie vooraf gekaderd.

Veiligheid en Preventie

In lijn met de **"zero death" ambitie** van de SER met betrekking tot gevaarlijke stoffen en ongevallen, is een **digitale registratie van de RI&E** en het **basiscontract** met de arbodienst verplicht. Digitale participatieplatforms dragen direct bij aan preventie door risico's sneller te signaleren en de fysieke en mentale belasting van de professional te spreiden over het netwerk.

5. Juridische Kaders, Privacy en Verantwoordelijkheid

De transitie naar digitale familieparticipatie vindt plaats binnen strikte juridische kaders. Transparantie mag nooit ten koste gaan van de juridische veiligheid van de organisatie of de medewerker.

Wet BIG en Toezichthoudende Plicht

De **Wet BIG** is niet van toepassing op mantelzorgers (niet-beroepsmatig). Zij mogen voorbehouden handelingen uitvoeren bij bewezen bekwaamheid en instemming van de cliënt. Echter, de instelling behoudt een **toezichthoudende plicht**: de professional moet de bekwaamheid verifiëren en afspraken over instructie en toezicht vastleggen in het zorgplan.

Regie via de Beheerder

Toegang tot medische gegevens via platforms wordt uitsluitend verleend door de **Beheerder** (cliënt of wettelijk vertegenwoordiger) via activatiecodes. De Beheerder is de enige die derden kan machtigen voor inzagerecht, waarmee de privacyborging bij het netwerk zelf ligt.

Niet-onderhandelbare Spelregels

Om de beheersbaarheid te garanderen, hanteert de organisatie de volgende 'harde' kaders:

- **Responstijden:** Maximaal 48 uur voor intramurale zorg. Voor de **thuiszorg (extramuraal)** geldt dat de reactie uitsluitend volgt tijdens het **eerstvolgende geplande zorgmoment**.
- **Discussieverbod:** Platforms zijn informatiekkanalen, geen discussie- of klachtenplatforms.
- **Communicatielij:** Contact verloopt uitsluitend via de eerste contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger.

6. Implementatiestrategie: Richten, Inrichten en Verrichten

Implementatie is geen IT-project, maar een veranderkundig proces onder direct mandaat van de Raad van Bestuur.

Het Drielagenmodel

1. **Richten (Strategisch):** De RvB mandateert de visie op netwerkzorg als kern van de overlevingsstrategie.

2. **Inrichten (Tactisch):** De technische integratie met het ECD wordt geborgd en de RI&E wordt digitaal geregistreerd bij de Arbeidsinspectie.
3. **Verrichten (Operationeel):** Professionals worden geschoold in de 5A-methode en getraind in het voeren van het 'behandelwensgesprek' (RIZA-notatie).

Monitoring en de CSI-Hard Stop

De Raad van Bestuur mandateert het gebruik van de **Caregiver Strain Index (CSI)** om institutionele aansprakelijkheid te beperken. Een **CSI-score ≥ 7 geldt als een 'Hard Stop'**: bij deze score is sprake van acute overbelasting van het netwerk. In dergelijke gevallen is onmiddellijke interventie via **Respijtzorg** (logeerzorg, dagopvang) verplicht om uitval van de informele zorg en daaropvolgende escalatie naar dure institutionele zorg te voorkomen. **Conclusie:** Digitale familieparticipatie is de spil in de overlevingsstrategie voor 2040. De Raad van Bestuur wordt opgeroepen om deze transformatie niet langer als innovatie te zien, maar als de noodzakelijke standaard voor professionele autonomie en zorgcontinuïteit.